TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 5 Viêm họng đặc hiệu

Tóm tắt từ bài giảng 6. VIEM HONG DAC HIEU.pdf (73 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU – SINH LÝ HỌNG
2. ĐẠI CƯƠNG VIÊM HỌNG
3. BẠCH HẦU HỌNG
4. VIÊM HỌNG VINCENT – VIÊM HỌNG DO LẬU CẦU
5. VIÊM HỌNG DO SIÊU VI
6. VIÊM HỌNG MẠN ĐẶC HIỆU
7. KẾT LUẬN

1. GIẢI PHẪU – SINH LÝ HỌNG

- Họng gồm **họng mũi, họng miệng, họng thanh quản**; dễ nhiễm trùng, viêm họng rất phổ biến (Hoa Kỳ 2013: **khoảng 2%** lượt khám ngoại trú).
- **Mạch máu:** ĐM họng lên, ĐM bướm khẩu cái, ĐM khẩu cái lên. **Vận động:** TK lưỡi họng (IX), **dây X**, dây dưới lưỡi, dây VII.
- **Vòng Waldeyer** – mô lympho vùng họng; chức năng họng: **nuốt, thở, phát âm, nghe, miễn dịch**.
- **Miễn dịch** qua lớp biểu mô – lympho ở **các khe amidan**, chủ yếu ở **amidan khẩu cái**; khe ăn sâu, phân nhánh làm tăng "bề mặt hoạt động miễn dịch".
- **Chức năng amidan:** giám sát miễn dịch, **sản sinh lympho bào**, **sản sinh kháng thể đặc hiệu**, đưa tân cầu kích thích miễn dịch ra hốc miệng, ống tiêu hóa.

2. ĐẠI CƯƠNG VIÊM HỌNG

- Thuật ngữ quốc tế: **Pharyngitis** hoặc **Angina** (từ cổ xưa); là phản ứng viêm niêm mạc và cấu trúc dưới niêm mạc họng.
- **Nhiễm trùng: virus 40 – 80%**; vi khuẩn ở **trẻ sơ sinh 30 – 40%**, **người lớn 5 – 10%**.
- **Không nhiễm trùng: GERD**, thứ phát sau viêm mũi xoang, dị ứng, hóa chất, **thuốc lá**.
- **Sinh lý bệnh:** mất cân bằng vi sinh gây bệnh / không gây bệnh; vòng Waldeyer tham gia đáp ứng miễn dịch; **đám rối họng** rất nhạy cảm.
- **Phân loại Escat (viêm họng cấp): không đặc hiệu**, **đặc hiệu**, **do bệnh máu**.

Viêm họng cấp đặc hiệu	
Nhiễm khuẩn	Bạch hầu họng, Vincent, lậu cầu
Nhiễm siêu vi	Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, Herpangina (Coxsackie), Herpes, Zona
Mạn đặc hiệu	Giang mai, lao, HIV/AIDS

3. BẠCH HẦU HỌNG

- Tác nhân **Corynebacterium diphtheriae**; viêm họng **màng giả** (viêm họng trắng); tuổi **1 – 9**, lây đường hô hấp; ủ bệnh **2 – 6 ngày**.
- **Màng giả**, hạch cổ sưng to dần, đau → **"bull-neck"**; có thể lan **mũi, thanh quản**.
- Chẩn đoán: cấy môi trường **Krebs – Loeffler** (mọc sau **36 – 48 giờ**); BC tăng (đến **25.000/mm³**, tăng neutrophil); **albumin niệu**.
- **Phân biệt viêm amidan cấp:** bạch hầu **không tiêm chủng**, khởi phát **âm ỉ**, đau họng **nhẹ**, **sốt nhẹ**, **mạch nhanh không tương xứng nhiệt độ**, màng giả **lan ra ngoài amidan, khó bóc, để lại nền chảy máu**, có albumin niệu, tử vong cao.

- **Điều trị: kháng độc tố (ADS) càng sớm càng tốt**:
  - **20.000 – 40.000 đơn vị:** bệnh sử **< 48 giờ** hoặc màng giả **chỉ trên amidan**.
  - **80.000 – 120.000 đơn vị: > 48 giờ** hoặc màng giả **lan ra ngoài amidan**.
  - **Penicillin 600 mg/6 giờ × 7 ngày** (dị ứng: **erythromycin 500 mg/6 giờ**); theo dõi biến chứng, dinh dưỡng; **cách ly 2 – 4 ngày**.

4. VIÊM HỌNG VINCENT – VIÊM HỌNG DO LẬU CẦU

Vincent (viêm họng cấp hoại tử, viêm họng loét – màng)

- **Người trẻ, đề kháng giảm**; toàn thân **ít rối loạn**.
- **4 triệu chứng: đau họng dữ dội**, khó nuốt, **thở hôi**, **sưng hạch góc hàm một bên**.
- Màng giả **một bên amidan**, **xám, mủn, dễ bong**; loét có xu hướng hoại tử, **sờ không thâm nhiễm cứng**; lợi sưng, loét, dễ chảy máu.
- Chẩn đoán: tính chất màng giả + quệt họng, nuôi cấy; phân biệt bạch hầu, giang mai, bệnh máu, tăng BC đơn nhân.
- Điều trị: **Penicillin G 5 – 7 ngày** (thay thế **tetracycline**) + **vệ sinh răng miệng**.

Lậu cầu – song cầu Gram âm **Neisseria gonorrhoeae**

- Ủ bệnh nam **2 – 6 ngày** (2 – 14); **50 – 84% không triệu chứng** (Hoff).
- Đau họng, nuốt đau, ngứa họng; hạch cổ chỉ **9 – 10%**; niêm mạc phù nề, ban đỏ; amidan sưng đỏ, **xuất tiết trắng vàng** ở hốc amidan, lưỡi gà, màn hầu.
- Điều trị: **ceftriaxone tiêm bắp 1 liều** + **azithromycin 1 liều** (điều trị đồng thời **Chlamydia trachomatis**).

5. VIÊM HỌNG DO SIÊU VI

Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng ("sốt do viêm tuyến") – **virus Epstein – Barr**

- Lây qua **nước bọt**; chủ yếu **thanh thiếu niên**; hiếm trong năm đầu đời.
- Đau họng nhiều, **xuất huyết rải rác ở màn hầu, khẩu cái mềm**; màng xuất tiết xám → màng giả dễ bong, **cả 2 bên**.
- Hạch xuất hiện trước ở **tam giác cổ sau**; **lách to (50%)**, gan to (10 – 15%); hiếm: liệt dây sọ, **Guillain – Barré**.
- Chẩn đoán: BC tăng từ tuần 2 (**> 30.000/mm³**), **mono có thể > 90%**; **Monospot / Paul – Bunnell** (nhạy **86%**, đặc hiệu **99%**).
- Điều trị: đa số **tự khỏi**; triệu chứng; **prednisolon 40 – 80 mg** rồi giảm dần 7 – 10 ngày; KS chỉ khi bội nhiễm.

Herpangina – **Coxsackie A**

- Lành tính, trẻ **3 – 10 tuổi**, **mùa hè**; lây qua nước bọt, dịch, phân; ủ bệnh 4 – 6 ngày.
- Sốt cao đột ngột, đau cơ, nôn → đau họng, **đa tiết nước bọt**; **mụn nước nhỏ ở khẩu cái mềm, trụ trước amidan** ("**chuỗi hạt ngọc**").
- **Không có thuốc đặc trị** → điều trị triệu chứng, súc họng nước muối, nghỉ ngơi.

Herpes – **HSV-1** (phổ biến hơn HSV-2)

- Trẻ **2 – 5 tuổi**; phù nề, đỏ niêm mạc họng và **lợi**, mụn nước vỡ nhanh → **loét nông**; **tự khỏi 1 – 2 tuần**.
- KS và kháng viêm **không tác dụng**; **acyclovir** uống 10 ngày.

Zona họng – **Herpes Zoster**

- Tác động **rễ sau hạch thần kinh**, nặng ở **suy giảm miễn dịch**.

- Đau rát, khó nuốt; mụn nước **một bên**, theo vùng **TK hàm trên**, quầng đỏ, vỡ thành loét đa vòng; **dừng ở ranh giới khẩu cái – màn hầu** (đường giữa).
- **Acyclovir 10 mg/kg/8 giờ × 7 ngày**, càng sớm càng tốt; corticoid phòng đau kéo dài.

6. VIÊM HỌNG MẠN ĐẶC HIỆU

Giang mai họng – xoắn khuẩn **Treponema pallidum**; bẩm sinh hoặc mắc phải.

- **Thời kỳ I: săng** – vết trợt / loét nông ở môi, lưỡi, màn hầu, amidan, **không đau, nền chắc**; kéo dài 2 – 8 tuần; hạch cùng bên.
- **Thời kỳ II: mảng nhầy**, loét **"dãy ốc sên"**, không đau, màu **xám bạc**, bờ đỏ.
- **Thời kỳ III: gôm giang mai** (cục cứng ~1 cm → mềm → loét chảy dịch vàng **không phải mủ**, bờ thẳng đứng, đáy đỏ sạch); **mảng bạch sản** trắng đục như sứ.
- Chẩn đoán: **TPI** (bất động xoắn khuẩn) **đặc hiệu 100% ở giai đoạn II, III**.
- Điều trị: **Penicillin 2,4 triệu UI tiêm bắp 1 liều** (thời kỳ I, II); giai đoạn trễ: **1 liều/tuần × 3 tuần**; thay thế tetracycline, erythromycin.

Lao họng – **Mycobacterium tuberculosis**; ~1/3 dân số thế giới nhiễm lao.

- **Lao kê họng:** nhiều **hạt nhỏ 1 – 2 mm** như hạt kê, lưỡi gà sưng, màn hầu kém di động; hạt vỡ → loét nông; hạch cổ to.
- **Lao loét bã đậu:** nuốt khó, **nuốt đau lan lên tai**, sặc, chảy nước bọt; loét nông, **đáy xám bẩn, bờ nham nhở**, ở trụ amidan, màn hầu, hạ họng; tiến triển **mất chất**.

Viêm họng do HIV/AIDS

- Màng giả, **nấm**, ban đỏ, mảng trắng; amidan phủ giả mạc trắng nhạt, dính; tăng sản hạch vùng hầu họng.
- Nhiễm trùng kéo dài **> 8 tuần**, **không tiến triển thành áp xe / viêm tấy quanh amidan**; chẩn đoán **ELISA + Western blot**.

7. KẾT LUẬN

- Viêm họng đa dạng; **đồng nhất viêm với nhiễm khuẩn → lạm dụng kháng sinh**. Nhận diện tổn thương đặc hiệu từng tác nhân giúp điều trị hợp lý.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 6. VIEM HONG DAC HIEU.pdf khi cần chi tiết.